

Datei: 10\_email\_ehemann.eml

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Von     | samir.tunc@privatpost.de          |
| An      | rentenberater@privatpost.de       |
| Datum   | Tue, 30 Jun 2026 22:41:00 +0200   |
| Betreff | Therapieslot und Angst vor Kosten |

Guten Abend,

Leyla will nicht, dass wir alles verkaufen für ein Medikament, das vielleicht nicht wirkt. Gleichzeitig sagt die Klinik, dass wir das Fenster nicht verpassen dürfen. Ich brauche eine klare Liste, was das Gericht vor dem 18. Juli wirklich sehen muss.

Bitte sagen Sie auch, welche Unterlagen von der Schule wichtig sind. Leyla versucht noch Korrekturen zu machen, aber sie kann kaum 20 Minuten lesen.

Viele Grüße

Samir Tunc

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Von     | Klinikapotheke Mainz <sonderbeschaffung@unimedizin-mainz.de> |
| An      | "Prof. Dr. Miriam Strauß" <m.strauss@unimedizin-mainz.de>    |
| Datum   | Fri, 10 Jul 2026 13:54:00 +0200                              |
| Betreff | UM 26-NI-4471 - Neravexor Lieferfenster und Preisbestätigung |

Sehr geehrte Frau Professor Strauß, der Hersteller hat für eine Einzeldosis Neravexor einen Nettopreis von 480000 Euro zuzüglich Transport und Kühlkettenmonitoring bestätigt. Die Reservierung gilt bis 17. Juli 12 Uhr. Danach wird die Charge anderweitig vergeben. Eine Rückgabe nach Freigabe des Transports ist ausgeschlossen.

Die Lieferung könnte frühestens am 27. Juli eintreffen. Das Präparat muss zwischen zwei und acht Grad gelagert und innerhalb von 36 Stunden nach Entnahme aus der Transportbox verwendet werden. Für die Zubereitung benötigen wir die endgültige Dosisberechnung, das aktuelle Gewicht und die schriftliche Kostenfreigabe. Eine Bestellung ist bislang nicht ausgelöst worden.

Der Hersteller hat außerdem ein Registerformular und die Meldung jeder schwerwiegenden Reaktion verlangt. Bitte klären Sie, wer die Dokumentation übernimmt. Frau Mäßler aus der Apotheke hat am Montag Dienst und kann die Kühlkette mit der Station abstimmen. Diese Mail bestätigt nur Preis und Logistik, nicht die medizinische Eignung.

Freundliche Grüße  
Klinikapotheke Mainz  
sonderbeschaffung@unimedizin-mainz.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Universitätsmedizin Mainz - Klinik für Neurologie  
Betreff: Verlaufsdaten von Frau Lea Größenbach und geplante Behandlung mit Neravexor  
Unser Zeichen: UM 26-NI-4471  
Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

Datei: eml/2026-07-06\_sachstand\_nachforderung.eml

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | kanzlei-lindenhof@privatpost.de                                                                |
| An      | mandant@privatpost.de                                                                          |
| Datum   | Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200                                                                |
| Betreff | Sachstand und fehlende Unterlagen<br>krankenkassenrecht-off-label-use-seltene-erkrankung-mainz |

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 04\_kostenplan\_apotheke.csv

| position                          | menge | kosten_eur | notiz                  |
|-----------------------------------|-------|------------|------------------------|
| Neravexor Dosis 1                 | 1     | 480000     | Import und Zubereitung |
| Stationäre Überwachung<br>Dosis 1 | 1     | 12500      | 3 Tage                 |
| Neravexor Dosis 2                 | 1     | 480000     | 8 Wochen später        |
| Stationäre Überwachung<br>Dosis 2 | 1     | 12500      | 3 Tage                 |
| Begleitdiagnostik                 | 2     | 7800       | MRT Labor Liquor       |

Datei: 15\_verlauf\_labor\_gehstrecke\_2025\_2026.csv

| ■Datum     | Gehstrecke_M<br>eter | Hilfsmittel        | ALT_U_I | AST_U_I | Therapie               | Beobachtung              |
|------------|----------------------|--------------------|---------|---------|------------------------|--------------------------|
| 2025-01-14 | 420                  | keins              | 31      | 28      | Therapie A             | leichte Fatigue          |
| 2025-08-22 | 260                  | Gehstock           | 36      | 33      | Therapie A             | zwei Stürze              |
| 2026-02-18 | 170                  | Rollator           | 288     | 241     | Therapie B<br>beendet  | Leberwerte<br>erhöht     |
| 2026-05-11 | 110                  | Rollator           | 48      | 42      | keine<br>Basistherapie | erste Schlucks<br>törung |
| 2026-06-29 | 85                   | Rollstuhl<br>außen | 39      | 35      | Planung<br>Neravexor   | Fallboard<br>erfolgt     |

## Datei

Office-Dokument: 01\_mandatsnotiz\_eilverfahren.docx

## **Mandatsnotiz Eilverfahren Off-Label-Use**

### **1. Mandantin**

Mandantin ist Leyla Tunc, geboren am 16.11.1991, Grundschullehrerin aus Mainz. Diagnose: progrediente Autoimmun-Enzephalomyelitis mit seltenem Antikörperprofil, Schübe seit 2024, deutliche Gang- und Sehstörungen, kognitive Erschöpfung. Krankenkasse: RheinMain BKK.

### **2. Beantragte Behandlung**

Universitätsmedizin Mainz beantragt Neravexor, ein monoklonales Antikörperpräparat, zugelassen für eine andere seltene neuroimmunologische Indikation. Für Leylas Erkrankung besteht keine deutsche Zulassung. Klinik schlägt zwei Dosen im Abstand von acht Wochen vor. Kosten laut Klinikapotheke: 480.000 EUR je Dosis einschließlich Zubereitung und stationärer Überwachung.

### **3. Verfahren**

Antrag der Klinik 07.06.2026. MD-Gutachten 20.06.2026. Ablehnungsbescheid 24.06.2026, Zugang 26.06.2026. Geplanter stationärer Slot 18.07.2026. Widerspruch und Eilantrag müssen parallel vorbereitet werden.

### **4. Rentenberaterliche Perspektive**

Kurzfristig Krankenversicherungsanspruch und Eilrechtsschutz. Parallel: Krankengeld, Reha, mögliche Erwerbsminderung, Schwerbehindertenverfahren und dienstrechtliche Fragen nur koordinierend. Die Akte darf medizinische Hoffnung nicht mit rechtlicher Erfolgsaussicht verwechseln; die drei Off-Label-Kriterien müssen materialgestützt abgearbeitet werden.

## Datei

Office-Dokument: 02\_klinik\_antrag.docx



# **Klinikantrag Universitätsmedizin Mainz**

## **1. Medizinischer Stand**

Die Patientin leidet an einer rasch progredienten Autoimmun-Enzephalomyelitis mit seltenem Antikörperprofil. Standardtherapien mit hochdosierten Steroiden, Plasmapherese, Rituximab und Cyclophosphamid führten nur zu vorübergehender Stabilisierung. Seit Mai 2026 neue Herde im MRT und Verschlechterung der Gehstrecke auf unter 200 Meter.

## **2. Behandlungsziel**

Neravexor soll die Krankheitsprogression stoppen oder verlangsamen, Schubaktivität senken und den Verlust selbständiger Gehfähigkeit verhindern. Eine Heilung wird nicht versprochen. Die Klinik hält eine palliative und stabilisierende Wirkung für realistisch.

## **3. Evidenzmaterial**

Die Klinik legt eine Phase-II-Studie zur verwandten Antikörpergruppe, zwei Fallserien, ein Registersignal und eine Stellungnahme des europäischen Referenzzentrums vor. Eine Phase-III-Studie für exakt diese Indikation existiert nicht. Die Klinik argumentiert mit Seltenheit, Pathomechanismus und fehlender Alternative.

## Datei

Office-Dokument: 03\_md\_gutachten\_ablehnung.docx

## **MD-Gutachten, Auszug**

### **1. Ergebnis**

Der MD empfiehlt Ablehnung der Kostenübernahme. Es liege ein Off-Label-Use außerhalb der arzneimittelrechtlichen Zulassung vor. Eine Empfehlung in der Arzneimittel-Richtlinie sei nicht ersichtlich. Für die konkrete Indikation fehle eine hochwertige Studie mit klinisch relevantem Nutzen.

### **2. Anerkannte Punkte**

Der MD erkennt die Schwere der Erkrankung und die erhebliche Teilhabebeeinträchtigung an. Standardtherapien seien weitgehend ausgeschöpft. Gleichwohl sei der Nutzen von Neravexor für diese Indikation nicht hinreichend belegt.

### **3. Angriffspunkte**

Das Gutachten setzt sich nur knapp mit der Registerauswertung und der Stellungnahme des Referenzzentrums auseinander. Es prüft nicht ausdrücklich, ob eine notstandsähnliche Situation nach Paragraf 2 Abs. 1a SGB V in Betracht kommt. Für den Eilantrag braucht es eine ärztliche Zusatzstellungnahme zu Prognose ohne Behandlung.

## Datei

Office-Dokument: 05\_studienlage\_arbeitsnotiz.docx

## **Arbeitsnotiz Studienlage**

### **1. Material der Klinik**

Die Klinik legt keine Phase-III-Studie für exakt Leylas Indikation vor. Vorhanden sind eine kleine kontrollierte Phase-II-Studie bei verwandter Erkrankung, zwei Fallserien mit insgesamt 19 Patienten, ein Registersignal und ein Expertenbrief. Das Material ist medizinisch ernst zu nehmen, rechtlich aber angreifbar.

### **2. Rechtliche Sortierung**

Für den allgemeinen Off-Label-Use werden typischerweise schwere Erkrankung, fehlende Therapiealternative und begründete Erfolgsaussicht verlangt. Bei notstandsähnlicher Lage nach Paragraf 2 Abs. 1a SGB V kann die Prüfung anders akzentuiert sein, bleibt aber nicht evidenzfrei. Der Schriftsatz muss beides trennen.

### **3. Benötigte Ergänzung**

Die Klinik soll bis 06.07.2026 beantworten: Wie schnell droht irreversible Verschlechterung? Welche Standardtherapie ist konkret ausgeschöpft? Welche objektiven Marker sprechen für Neravexor? Welches Risiko entsteht durch Abwarten bis Hauptsacheentscheidung?

## Datei

Office-Dokument: 06\_krankenkasse\_bescheid.docx

## **Ablehnungsbescheid RheinMain BKK**

### **1. Entscheidung**

Die Kostenübernahme für Neravexor wird abgelehnt. Die beantragte Behandlung sei nicht Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung für die vorliegende Indikation und erfülle nach MD-Bewertung nicht die Voraussetzungen einer ausnahmsweisen Leistung.

### **2. Begründung**

Die Kasse verweist auf fehlende Zulassung, fehlende G-BA-Empfehlung, nicht ausreichende Evidenz und Wirtschaftlichkeit. Sie bietet eine erneute Beratung zu symptomatischer Therapie, Physiotherapie und Rehabilitation an.

### **3. Frist**

Bescheid vom 24.06.2026, Zugang 26.06.2026. Widerspruchsfrist 26.07.2026. Wegen Behandlungsslot am 18.07.2026 ist Eilrechtsschutz vorher erforderlich.

## Datei

Office-Dokument: 07\_widerspruch\_entwurf.docx



## **Widerspruchsentwurf**

### **1. Antrag**

Gegen den Bescheid vom 24.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Übernahme der Kosten für die Behandlung mit Neravexor gemäß Antrag der Universitätsmedizin Mainz.

### **2. Begründung**

Die Mandantin leidet an einer schwerwiegenden, rasch progredienten Erkrankung. Standardtherapien wurden ausgeschöpft oder sind medizinisch nicht mehr erfolgversprechend. Die Klinik legt eine pathophysiologisch begründete und durch Studien- sowie Registermaterial gestützte Erfolgsaussicht dar. Die Kasse und der MD haben die notstandsähnliche Lage und die konkrete Prognose ohne Behandlung nicht ausreichend gewürdigt.

### **3. Nachreichung**

Eine ergänzende fachärztliche Stellungnahme zur Dringlichkeit, Alternativlosigkeit und Nutzenwahrscheinlichkeit wird bis 08.07.2026 nachgereicht.

## Datei

Office-Dokument: 08\_eilantrag\_sozialgericht.docx

## **Eilantrag Sozialgericht, Arbeitsfassung**

### **1. Antrag**

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, der Antragstellerin vorläufig die Kostenübernahme für die Behandlung mit Neravexor entsprechend dem Therapieplan der Universitätsmedizin Mainz zu gewähren.

### **2. Anordnungsanspruch**

Der Anspruch wird auf die außergewöhnliche Schwere, die fehlende Standardalternative, die fachärztlich begründete Erfolgsaussicht und die besondere Dringlichkeit gestützt. Der Schriftsatz muss offenlegen, dass die Evidenz nicht dem Regelfall entspricht, und erklären, warum dies bei der Seltenheit und Progression nicht zur Ablehnung führen darf.

### **3. Anordnungsgrund**

Der Therapieslot am 18.07.2026 ist reserviert. Nach Klinikangabe drohen bei weiterem Schub irreversible Gang- und Sehverschlechterungen. Abwarten bis zur Hauptsacheentscheidung würde den möglichen Nutzen der Behandlung entwerten.

## Datei

Office-Dokument: 09\_folgepruefung\_krankengeld\_rente.docx

## **Folgeprüfung Krankengeld, Reha und Rente**

### **1. Leistungsübersicht**

Leyla Tunc ist seit 03.05.2026 arbeitsunfähig. Entgeltfortzahlung läuft voraussichtlich bis 14.06.2026, danach Krankengeld. Schwerbehindertenantrag wurde noch nicht gestellt. Reha war wegen instabiler Erkrankung zurückgestellt.

### **2. Rentenberaterliche Folgearbeit**

Krankengeldfrist, Reha-Antrag, Schwerbehindertenrecht und Erwerbsminderungsrente müssen in einem Fristenblatt geführt werden. Der Off-Label-Eilantrag hat Vorrang, aber die medizinischen Unterlagen sollen so abgelegt werden, dass sie später für Reha, GdB und Erwerbsminderung wiederverwendbar sind.

## Datei

Office-Dokument: 13\_neurologischer\_verlaufsbericht\_neravexor.docx

## Universitätsmedizin Mainz - Klinik für Neurologie

Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz  
Telefon 06131 17-0 | seltene-neuro@unimedizin-mainz.de

Bergland Krankenkasse  
Leistungsmanagement Arzneimittel  
Postfach 9042  
65080 Wiesbaden

Mainz, 10. Juli 2026

**Betreff: Verlaufsdaten von Frau Lea Größenbach und geplante Behandlung mit Neravexor**  
**Unser Zeichen: UM 26-NI-4471**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Frau Größenbach wird seit Oktober 2024 wegen einer fortschreitenden neuroimmunologischen Erkrankung in unserer Spezialambulanz behandelt. Trotz zweier standardisierter Therapieversuche nahm die Gehstrecke von 420 Metern im Januar 2025 auf 85 Meter im Juni 2026 ab. Seit April benötigt sie außerhalb der Wohnung einen Rollstuhl. Schluckstörungen traten erstmals im Mai auf; eine Ernährungssonde ist derzeit noch nicht erforderlich.

Die bisherigen Medikamente wurden in ausreichender Dosis und Dauer gegeben. Unter dem zweiten Präparat kam es zu einer schweren Leberwerterhöhung, weshalb die Behandlung am 18. Februar beendet wurde. Das interdisziplinäre Fallboard besprach Neravexor am 24. Juni. Vorgesehen ist zunächst eine Dosis mit stationärer Überwachung und engmaschigen Laborwerten; eine weitere Gabe soll erst nach Auswertung des Verlaufs entschieden werden.

Der Bericht dokumentiert Befunde, Vorbehandlungen und den geplanten Ablauf. Die Patientin wurde darüber aufgeklärt, dass für ihre konkrete Erkrankung keine Zulassung besteht und die verfügbare Fallzahl klein ist. Sie und ihr Ehemann wünschen dennoch die erneute Prüfung. Befundkopien, Aufklärungsbogen und Laborverlauf sind beigelegt; die Originale verbleiben in der Krankenakte.

Mit freundlichen Grüßen

Professor Dr. Miriam Strauß  
Oberärztin der Spezialambulanz

Anlage: 15 verlauf labor gehstrecke 2025 2026 (CSV-Export)